

Vertiges

AVC URGENCE

- Paralysie du visage
- Paralysie du bras ou jambe
- Trouble de la parole
- Trouble de la vue
- Vertiges violents
- Maux de tête intense

4D

4H
Hoquet
Horner
Hémisyndrome
Hallux (Babinski)

1. Rechercher des drapeaux rouges
 - a. **Céphalées** inhabituelles
 - i. *Est-ce que vous avez aussi mal à la tête ?*
 - b. Début **soudain**
 - i. *Comment est-ce que c'est apparu ?*
 - c. **Ne tient pas debout** (périphérique arrive à tenir mais ont peur)
 - i. *Est-ce que vous arrivez à marcher ?*
 - d. Anomalie neuro
 - i. Dysarthrie, Dysphagies, Diplopie, Dysphonie
 1. *Est-ce que vous trouvez que vous avez de la peine à articuler ?*
 2. *Est-ce qu'on vous demande de répéter ce que vous dites parce qu'on a de la peine à comprendre quand vous parlez ?*
 3. *Est-ce que vous avez de la peine à avaler ?*
 4. **Diplopie binoculaire** / parésie oculomotrice (**jamais de diplopie si vertige périphérique**) : *Est-ce que vous voyez double ?*
 - ii. **Nystagmus**
 1. Vertical
 2. Multidirectionnel
 3. Dysconjugué (les deux yeux ne font pas la même chose)
 4. **Horizonto (rotatoire) est en général périphérique (DVB)**
 - iii. **Hémisyndrome** spinothalamique (douleur, chaleur)
 - iv. **Hoquet**
 1. *Est-ce que vous avez eu le hoquet ?*
 - v. Syndrome de **Horner** (myosis, ptosis)
 - vi. **Skew deviation** = divergence vertical statique et non paralytique de la position des yeux. Des fois sans diplopie, mise en évidence avec le **alternate cover test** (couvrir alternativement chaque œil et voir s'il existe une saccade de correction verticale)
2. Caractériser le vertige
 - a. Constant ? au mouvement, brusque ?
 - b. Pièce qui tourne ? ou comme si tangué ?
3. Autres symptômes ?
 - a. Nausée – vomissement
 - b. Autre
4. ATCD personnels
5. ATCD familiaux
6. Habitudes
 - a. Tabac
 - b. Alcool
 - c. Drogue

Examen clinique

- Orientation
 - Comment vous-vous appelez ?
 - Où êtes-vous ?
 - Quelles dates sommes-nous ?
- Marche
 - Normal
 - Pointe / talon
 - **Funambule**
- **Romberg (main tendue d'abord yeux ouverts ensuite avec fermés)**
- **Doigt-nez**
- **Marionnette**
- **Rebond pathologique**
- **Talon-genou-descendre le long du tibia**
- **Réflexe (!!! comparer des 2 côtés)**
 - Tricipital (C7)
 - Bicipital (C5)
 - Stylo-radial (C6)
 - Rotulien (L3-L4)
 - Achilléen (S1)
- **Hallpike**
- **Head impulse test**
- Palpation muscle
- Nerfs crâniens
- Membre sup force contre résistance
 - Épreuve bras tendu (DDC)
 - Abduction latérale (DDC)
 - Rotation latérale épaule (DDC)
 - Flexion avant-bras
 - Extension bras
 - Flexion poignet
 - Extension poignet
 - Abduction des doigts (ouvrir doigt contre pression)
 - Flexion des doigts (doigt en crochet)
 - Extension des doigts (paume vers le bas)
- Membre inf force contre résistance
 - Épreuve jambes fléchies
 - Flexion hanche
 - Extension hanche (main sous pied)
 - Flexion genou
 - Extension genou
 - Flexion pied (tirer patient en bas de la table)
 - Extension pied
 - Flexion gros orteil
 - Extension gros orteil
- Babinski
- Sensibilité : tact global



Patho yeux ouverts : cervelet Patho yeux fermés seulement : vestibulaire
--

DD

AVC (syndrome cérébelleux aigu) :

- Vertiges intenses d'installation brusque
- Impossibilité à tenir debout
- Nausées, vomissement
- Céphalées
- **Déficit neurologique** (<50%) → NIHSS 0
 - o Symptômes du TC
 - Diplopie
 - Dysarthrie
 - Dysphagie
 - Hoquet
 - Nystagmus

Gayer- Wernicke :

Se présente chez des pts éthylique et dénutri. On observe les symptômes suivants :

- Confusion
- Nausée
- Oscillopsie
- Trouble de l'équilibre
- Dysarthrie
- **Troubles oculomoteurs**
 - o Ophtalmoplégie
 - o Nystagmus spontané
 - o Ataxie oculaire
- **Confusion**
- **Ataxie statique / cinétique**

Triade

	DVB	VPPB
Physiopathologie	Neuropathie du n. VII → déficit d'input unilatéral se manifestant sur le plan horizontal	Cristal dans un canal semi-circulaire → suractivation paroxystique d'un canal
Chronologie	Constant	Aux mouvements
Clinique	Grands vertiges et nystagmus constants Syndrome vestibulaire harmonieux Nausées, vomissement	Vertiges et nystagmus brusques Nausée, vomissement
Nystagmus	Horizonto-rotatoire (battant du côté de l'oreille saine) Constant	Selon l'axe du canal touché
Test diagnostic	Manœuvre de Halmagyi = Head impulse test	Manœuvre de Hallpike (supine roll test pour le canal horizontal)

Vertiges

1. AA

- lipothymie vs. vertiges
- symptômes auditifs (perte auditive, acouphène)
- durée
- contexte (position, suite à un trauma)
- symptômes associés (troubles visuels, nausées, infections des voies aériennes supérieures)
- douleurs cervicales, blessure
- médication actuelle
- antécédents d'ATS, FRCV

2. Status

- signes vitaux
- examen neurologique complet
- Romberg (examen se fait sans les chaussures, pieds joints et bras tendus devant, position maintenue d'abord avec les yeux ouverts, puis fermés)
- nystagmus
- Tilt (avec table d'inclinaison) ou Hallpike test (patient assis, tête orientée à 45° vers l'oreille testée et allonger le patient avec nuque en extension et attendre 1 minute)
- Head impulse test ou Halmagyi
- démarche
- audition
- Weber et Rinne
- examen ORL
- examen CV

3. DD

- Maladie de Ménière (acouphènes, nausées, perte d'audition)
 - o FSC, sérologie syphilis, IRM, Hallpike négatif
- hypotension orthostatique sur déshydratation
 - o A debout-assis, FSC, électrolytes, leucocytes selles
- hypotension orthostatique médicamenteuse
 - o TA debout-assis, FSC, électrolytes, ECG, IRM
- vertige positionnel bénin (vertiges sur certains mouvements, chambre tourne autour)
 - o Hallpike positif, IRM, audiogramme
- labyrinthite (perte d'audition, nausées, infections des voies aériennes supérieures)
 - o audiogramme, IRM
- neurinite vestibulaire (nausées, infections des voies aériennes supérieures, pas de perte d'audition)
 - o FSC, électrolytes, IRM
- neurinome (perte d'audition progressive unilatérale)

4. Significations des tests

- Romberg latéralisé (syndrome vestibulaire central ou périphérique), Romberg positif (atteinte proprioceptive, déviation lors de la fermeture des yeux ou aggravée par la fermeture des yeux), Romberg négatif (syndrome cérébelleux, instabilité non aggravée par la fermeture des yeux)

- nystagmus périphérique quand unidirectionnel (vestibule, nerf vestibulaire VIII, noyau vestibulaire) et nystagmus central si multidirectionnel
- Hallpike : si nystagmus alors vertige paroxystique positionnel bénin (otolithes dans canaux semi-circulaires antérieurs)
- Halmagyi : si un œil doit faire une cascade correctrice alors déficit vestibulaire (saccade correctrice quand on tourne la tête du patient à droite = déficit canalaire droit)
- Weber (latéralisation du côté atteint si surdité de transmission, latéralisation du côté sain si surdité de perception)
- Rinne (surdité de transmission si $CA < CO$, surdité de perception si $CA = CO$)